

UVEÍTIS

Ana Garrote Llordén, Marta Cuesta Lasso, Andrea Carrancho García.

INTRODUCCIÓN

La úvea es la capa vascular del ojo. Está formada por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. La uveítis es la inflamación de dichas estructuras. Cuando la inflamación afecta a todas las estructuras de la úvea se denomina panuveítis.

UVEÍTIS ANTERIOR

Es la forma más habitual de uveítis, consiste en la inflamación del iris y de la parte anterior del cuerpo ciliar. El origen idiopático es el más frecuente. En ocasiones se debe a una enfermedad local (cirugía previa, endoftalmitis, queratitis), sistémica (espondilitis anquilosante, sarcoidosis, enfermedad de Behçet) o infecciosa (tuberculosis [TBC], sífilis).

Diagnóstico

Habitualmente los pacientes se quejan de dolor, en ocasiones precedido de molestias oculares, fotofobia y visión borrosa. Con frecuencia refieren haber tenido episodios previos con síntomas similares.

A la exploración podemos encontrar hiperemia conjuntival de predominio ciliar, miosis pupilar y tensión ocular baja (elevada en algunos casos). Puede haber alteraciones iridianas, tales como atrofia, nódulos, neovascularización y sinequias posteriores (adherencias del borde del iris a la cara anterior del cristalino que provocan irregularidad pupilar).



Uveitis anterior con membrana pupilar tras cirugía de catarata.

La celularidad en cámara anterior es un marcador de actividad inflamatoria. Se puede apreciar enfocando un fino haz de luz de la lámpara de hendidura entre el iris y el endotelio corneal. Se acompaña con frecuencia de turbidez en cámara anterior, exudado fibrinoso, hipopion (nivel horizontal inferior por depósito celular) y precipitados retroqueráticos (depósitos de células inflamatorias en el endotelio corneal).



Precipitados retroqueráticos en uveítis anterior, técnica de transiluminación con la lámpara de hendidura.

Tratamiento en urgencias

- Corticoides tópicos: colirio de prednisolona o dexametasona, una gota cada 1-4 horas los primeros días en función del grado de inflamación, seguido de una pauta descendente.
- Ciclopléjicos: colirio de ciclopentolato, una gota cada 12 o 24 horas si la inflamación es leve o moderada; atropina cada 24 horas en inflamación grave. Calman el dolor y evitan la formación de sinequias posteriores.

Es conveniente remitir a todo paciente con diagnóstico de uveítis al oftalmólogo para examen del fondo de ojo y reevaluación, ya que algunos casos pueden requerir la administración de corticoide subconjuntival o intravítreo.

UVEITIS INTERMEDIA Y POSTERIOR

Hablamos de uveítis intermedia para referirnos a procesos inflamatorios de la pars plana y del vítreo anterior. Llamamos uveítis posterior a aquel trastorno inflamatorio que ocurre en estroma o vasculatura de coroides y / o retina.

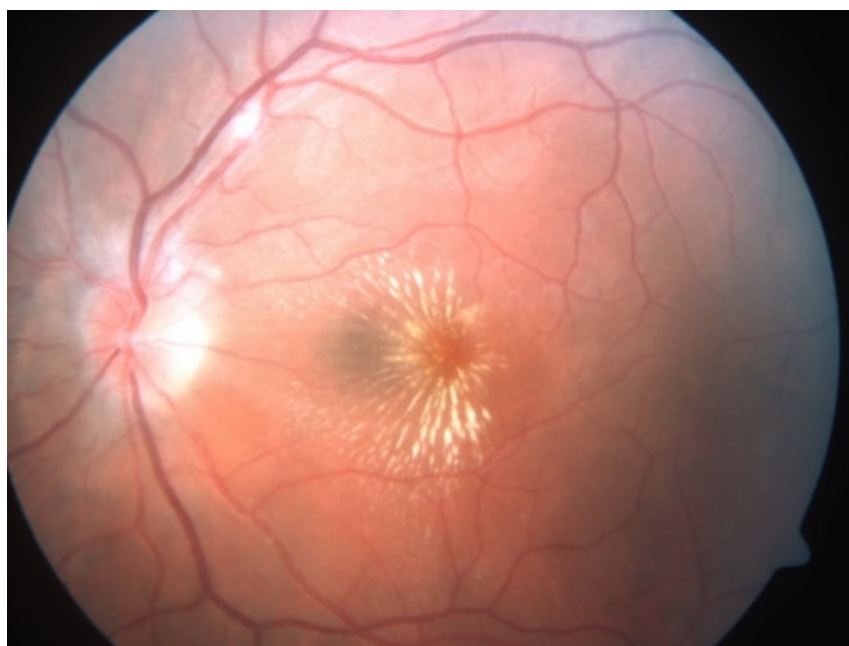
Diagnóstico

Se basa en una completa anamnesis. Los datos demográficos y los antecedentes médicos o quirúrgicos pueden darnos pistas de la causa de la inflamación. En nuestro medio es especialmente importante descartar estados de inmunosupresión.

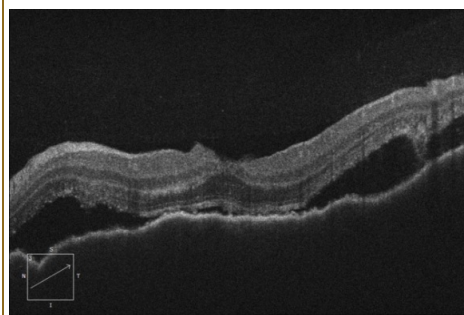
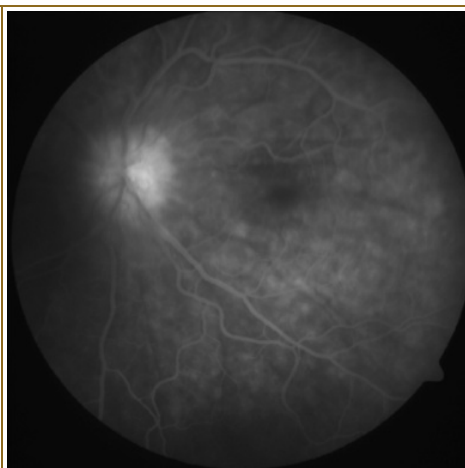
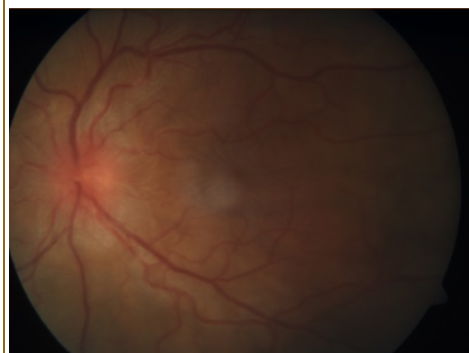
La clínica más habitual consiste en disminución de agudeza visual, visión borrosa, fotopsias, miodesopsias y / o escotomas. Debemos indagar sobre su lateralidad, su curso clínico (agudo o progresivo), episodios previos, signos y síntomas sistémicos asociados. Todo ello ayuda a orientar el diagnóstico de sospecha.

La exploración inicial va encaminada a determinar la localización anatómica de la inflamación y la gravedad de la misma. Debe incluir agudeza visual, reflejos pupilares, tonometría, examen con lámpara de hendidura y fondo de ojo bajo midriasis farmacológica.

En estos tipos de uveítis no suele haber importante inflamación en cámara anterior. En la uveítis intermedia son característicos la vitritis anterior (celularidad o Tyndall vítreo, visible al enfocar el haz de luz de la lámpara de hendidura a vítreo anterior), los snowballs (agregados de células con aspecto blanquecino) que pueden acumularse y formar snowbanks (placas blanquecinas en la zona inferior de la pars plana*). En la uveítis posterior los signos pueden ser muy variados: vitritis posterior, hemorragias y exudados retinianos, retinitis (infiltrados retinianos blanquecinos), papilitis...



Retinografía de paciente con uveítis posterior por *Bartonella henselae**. Se aprecian papilitis y estrella macular



Retinografía, angiografía con fluoresceína y OCT macular de paciente con síndrome de Vogt – Koyanagi – Harada (ojo izquierdo). Aparece papilitis bilateral con múltiples puntos hiperfluorescentes en retina y múltiples desprendimientos retinianos serosos tabicados en polo posterior

La exploración oftalmológica puede completarse con pruebas como tomografía de coherencia óptica (OCT) o angiografía con fluoresceína (AFG) para detectar otros signos como vasculitis o edema macular.

Es imprescindible realizar una exploración física completa para descartar lesiones asociadas (alteraciones mucocutáneas, articulares, neurológicas).

Habitualmente es necesario solicitar pruebas de imagen y laboratorio para llegar a determinar la causa de la uveítis, siempre orientándonos por los datos obtenidos en la exploración previa.

Tratamiento en urgencias

El tratamiento depende de la etiología de la uveítis. Se emplea tratamiento antimicrobiano asociado a antiinflamatorio en caso de patología infecciosa, y debe iniciarse tratamiento antibiótico empírico ante su sospecha. Si la uveítis es debida a alteraciones inmunológicas se utiliza corticoide local (subtenoniano o intravítreo) o sistémico y, en algunos casos, tratamiento inmunomodulador. Cuando nos encontramos ante una uveítis de origen tumoral, el tratamiento definitivo es el del tumor primario. En algunos casos es necesario asociar cirugía ocular para controlar la inflamación o para resolver complicaciones de la misma, como catarata o desprendimiento de retina.

INFECCIOSA
Parasitaria: por ejemplo Toxoplasmosis. Bacteriana: por ejemplo Tuberculosis y sífilis. Vírica: por ejemplo VIH, CMV. Fúngica: por ejemplo Histoplasmosis y candidiasis.
NO INFECCIOSA
Enfermedades autoinmunes: por ejemplo Sarcoidosis, Behçet, Wegener, Vogt-Koyanagi-Harada. Enfermedades exclusivamente oculares: por ejemplo Síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes, coroiditis serpinginosa.
SÍNDROMES MASCARADA
Neoplásicos: por ejemplo Melanoma, linfoma. No neoplásicos: escleritis múltiple, retinitis pigmentosa.

Diagnóstico diferencial de las uveítis intermedias y posteriores

BIBLIOGRAFÍA

- Maldonado López JM, Pastor Jimeno JC; Guiones de oftalmología: aprendizaje basado en competencias*. 2ª ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana; 2011.
- Ehlers JP, Shah CP. *The Wills Eye Manual: Office and Emergency Room Diagnosis and Treatment of Eye Disease*. 5ª ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2008.
- Moorthy RS, Davis J, Foster CS. Abordaje clínico de las uveítis. American Academy of Ophthalmology*. San Francisco: Elsevier; 2008.